

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TANGGAP DARURAT IPAL		
	No. Dokumen 215.1/I-SPO/IPSRS/IV/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 April 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada Malang  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian	Pengolahan air limbah adalah serangkaian proses yang bertujuan Tanggap darurat IPAL adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika terjadi kegagalan sistem, bencana, atau kecelakaan kerja pada fasilitas IPAL yang berpotensi mencemari lingkungan atau membahayakan keselamatan jiwa.		
Tujuan	1. Meminimalkan dampak pencemaran lingkungan akibat kebocoran atau kegagalan fungsi IPAL. 2. Melindungi keselamatan petugas, pasien, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit. 3. Menjadi panduan langkah-demi-langkah bagi petugas saat menghadapi situasi darurat di area IPAL.		
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 2. Peraturan Direktur tentang Pedoman Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan Rumah Sakit (MFK) No. .		
Prosedur	Jika terjadi : 1. Jika terjadi kebocoran IPAL maka lakukan Proses IPAL dihentikan sementara dan Periksa aliran inlet dan outlet 2. Jika hasil analisa melebihi baku mutu maka : 1) periksa proses yang berlangsung di IPAL, 2) lakukan penanganan sesuai penyimpangan 3) Periksa seluruh mesin dan peralatan IPAL, 4) lakukan penanganan sesuai penyimpangan 5) Periksa air limbah effluent setiap bulan 3. Listrik padam maka apabila aliran listrik utama di IPAL padam lebih dari 15 menit, maka : Hubungi penanggung jawab IPSRS bagian listrik untuk menyalakan genset. 4. Jika kerusakan <i>blower</i> bersifat mekanis dan membutuhkan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN IPAL		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	0 /I-SPO/DIR/IV/2026	00	2 / 3
	waktu perbaikan > 24 jam: 1) Batasi aliran air limbah yang masuk ke bak aerasi dengan memaksimalkan fungsi bak ekualisasi/penampung sementara. 2) Lakukan aerasi manual atau tambahkan pasokan oksigen portabel jika tersedia agar bakteri pengurai tidak mati (menghindari <i>shock loading</i>). 5. Air bau maka : 1) Pastikan lumpur terolah sempurna 2) Pastikan supply gelembung Unit Aerob berfungsi 3) Cek tabung klorinasi, isi ulang tablet klorin 6. Aliran macet : 1) Bersihkan saluran air limbah 2) Semprotkan pelumas baling-baling flowmeter 7. Kecelakaan Kerja : 1) Lakukan pertolongan pertama di tempat kejadian, 2) selanjutnya dibawa ke UGD untuk pertolongan medis 8. Tumpahan klorin/zat kimia: 1) Gunakan <i>Spill Kit</i> B3. Lokalisir tumpahan menggunakan pasir atau serbuk kayu 2) masukkan limbah kontaminasi ke dalam kantong plastik penanda B3 (sesuai regulasi). 9. Kebocoran dinding bak IPAL: 1) Segera matikan pompa transfer yang menuju ke bak bocor tersebut. 2) Alirkan/pompa sisa air limbah di bak yang bocor ke bak penampung darurat (<i>emergency pond</i>) atau bak ekualisasi yang kosong. 3) Laporkan ke Kesling dan IPSRS untuk dilakukan penambalan/perbaikan struktur beton segera 10. Penanganan Hasil Mutu Limbah Melebihi Ambang Batas / Ikan Mati: a. Jika ikan pada bak indikator mati massal atau hasil tes lapangan menunjukkan pH ekstrem (<6 atau >9): 1) TUTUP katup (<i>valve</i>) pembuangan akhir (<i>outfall</i>) yang menuju ke saluran drainase kota/sungai umum. 2) Alirkan kembali air limbah dari bak indikator/akhir ke bak ekualisasi awal (<i>re-sirkulasi</i>) untuk diolah ulang.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN IPAL		
	No. Dokumen 0 /I-SPO/DIR/IV/2026	No. Revisi 00	Halaman 3/ 3
	b. Tambahkan bahan penetral (kapur/soda ash jika terlalu asam, atau asam cuka jika terlalu basa) secara terukur pada bak ekualisasi. c. Ambil sampel air limbah darurat untuk dicek ke laboratorium guna mengetahui parameter apa yang melonjak tajam (BOD/COD/Ammonia).		
Unit Terkait	1. CS 2. IPSRS 3. MFK 4. Security		